

5 鉴别诊断: (1)小肝癌:一般直径 $\leq 2\text{cm}$,大部分为内部低回声,其包膜细薄,多有肝炎、肝硬化病史,AFP 可呈阳性,病灶早期动脉相明显强化,呈显著的结节状、团块状强化,可迅速下降为低回声或稍低回声,部分尚可见明显包膜。(2)肝转移瘤:病灶早期动脉相边缘或整个瘤体明显增强,但在门静脉期基本排出,延迟期很少出现充填。

参考文献

[1] 王纯正,徐智章 主编.超声诊断学(第二版)[M].北京:人民卫生出版社,1998.220—222.
[2] 李治安,刘吉斌等主编,临床超声影像学[M].北京:人民卫生出版社,2003.1317—1327.

(收稿日期:2009—05—20)

浅谈喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

李艳慧

(鹤岗矿业集团总医院,黑龙江 鹤岗 154100)

摘要 目的:分析喹诺酮类药物在临床应用中不良反应及药物相互作用的情况,为临床合理用药提供参考。方法:查阅相关文献分析、归纳、总结多年来不良反应报告及药物相互作用,结果:喹诺酮类药物临床表现不良反应多,可累及人体多个系统。结论:临床医生在关注喹诺酮类药物作用的同时,应高度重视其不良反应,合理应用,提高用药安全性。
关键词 喹诺酮;不良反应、药物相互作用

中图分类号: R 969 文献标识码: B 文章编号: 1673—6567(2009)06—0093—02

喹诺酮类药物是人工化学合成抗菌药物,自 20 世纪 60 年代合成第 1 个喹诺酮药物以来,人们对喹诺酮药进行结构修饰,使得该类药发展迅速,至今已有许多新品种应用于临床,由于该类药抗菌活性强、给药方便等特点,临床应用较广泛,同时不良反应报道也日渐增多。笔者通过查阅文献,总结其多年来不良反应报告及药物相互作用。发现该类药在肝肾、骨骼、皮肤、心脏、中枢神经等均有不良反应报告,并与多种药物发生相互作用。

1 不良反应

1.1 胃肠道反应:胃肠道反应是喹诺酮类药物最常出现的不良反应^[1],主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、消化不良、厌食、胃肠胀气、吞咽困难、流涎增多、便秘等,多在口服时发生,静脉给药也时有发生,停药后症状可逐渐恢复。喹诺酮类药物的所有品种都可发生胃肠道反应,只是这些症状的轻重及频繁程度可能有所差别,药物剂量及与其他抗菌药联用也是影响因素。

1.2 中枢神经系统不良反应:喹诺酮类药物治疗期间出现中枢神经系统不良反应比较普遍,主要有头痛、失眠、抽搐、等。陈晓玲等^[2]报告因咽痛发热而用氟罗沙星注射后出现舌体及四肢麻木,继之出现双上肢剧烈抽搐等神经症状。于波等^[3]报道 2 例氧氟沙星致老年震颤。

1.3 对心脏的毒性:截止到 1999 年 10 月,已有 7 例与服用格帕沙星有关的心脏猝死病例报告^[4]。这可能说明某些喹诺酮类药物存在着潜在的直接导致心率的变化,并且不同的品种发生的频率也不同,另外与用药的剂量有关。

1.4 软骨毒性:儿童及青少年长期服用此类药物,可能由于其对关节软骨的损害导致生长发育受阻。主要影响新生或幼小动物的骨骼增长板(除骺—关节复合体外)。一般为一过性、可逆性改变,对症处理或停药即可缓解^[5]。

1.5 光毒性反应:光毒性的临床表现为病人皮肤被阳光照射部分出现从中度的红斑到严重的大疱疹,并通常发生在春季。喹诺酮类药物光毒性与药物结构有密切关系,因此在不同药物之间存在的明显的差别。主要是其 8 位氟原子取代而引起的,一般来讲药物结构以 8 位氟取代物的最大,8 位甲氧取代物光毒性最小。

1.6 过敏反应:多应过敏性皮肤反应,以荨麻疹、红斑等皮疹多见;部分病例出现包皮水肿、双下肢凹陷性水肿。严重者呈过敏性休克^[6]。

1.7 肝、肾毒性:一般来说,患者对喹诺酮类药物耐受性良好;肾毒性罕见。使用环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星及培

氟沙星血浆肌酐浓度升高的发生率为 0.2~1.3%。左氧氟沙星、司帕沙星、格帕沙星和曲代沙星不会诱发晶尿液、间质性肾炎和急性肾功能障碍^[7]。从中可以看出喹诺酮类药物诱发肾功能障碍的发生率确实低。但其造成的后果严重,曾有报道因使用氧氟沙星出现少尿。所以在使用喹诺酮类药物特别对肾功能不全的老年患者,不可掉以轻心。肝毒性也很罕见,肝功能异常发生率为 1.5%,并且多数为一过性的。

总之,喹诺酮类药物的不良反应发生率说明左氧氟沙星是最安全的,总的不良反应发生率仅为 2.4%。而且其最主要的是胃肠道反应,光毒性低。洛美沙星、氟罗沙星、司帕沙星光毒性高;司帕沙星、格帕沙星心脏毒性高;肝肾功能不全慎用环丙沙星、诺氟沙星、培氟沙星及氧氟沙星。这就警告我们在使用药物中不但要注重药物的疗效,并要考虑到可能发生的不良反应,这样才能很好利用药物治疗作用,以达到安全地使用药物的目的。

2 药物相互作用

2.1 与其它抗菌药物合用:(1)氨基糖苷类这两类药物对于革兰阴性菌均有良好的抗菌活性,通过抑制 DNA 回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式以发生其协同作用,尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。(2) β -内酰胺类可阻碍细胞壁粘肽的合成,造成细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用。(3)利福平。利福平是肝药酶诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后致使喹诺酮抗菌活性降低,甚至消失。(4)其它抗菌药类合用使药效相加^[1]与磺胺嘧啶合用,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡萄菌的作用^[2]。环丙沙星与抗结核药物联用对非典型的分支杆菌具协同作用^[3]。诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效优于单用诺氟沙星者,同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好疗效。合用使毒副反应增加的有:^[1]喹诺酮类药物与氯霉素、红霉素合用可致效用降低,不良反应加重^[2]。环丙沙星与阿霉素、万古霉素、呋喃妥因合用,增加了其毒性,并且对肾功能不全者损害更大。

2.2 与其它类药物的相互作用:多价阳离子如镁、铝、钙、铁等均可降低本类药物的口服生物利用度。可与本类药物发生相互作用的药物主要的抗凝剂、非甾体类抗炎药,抗酸剂、硫酸铝、环孢素、茶碱和铁等。

目前临床应用抗感染药种类繁多,不包括合成类抗感染药物,仅抗生素就 200 多种,如此众多的抗感染药大量应用,不可避免出现一些问题。据专家统计,抗感染药处方中有 50%以上没必要或使用不当,滥用程度更甚,因而明确药物

耐药性、不良反应、相互作用与明确疗效同样重要。

参考文献

[1] 张学彬. 喹诺酮类药物的不良反应[J], 中国医药报, 2003, 6. 11.
[2] 陈晓玲, 陈晓东. 氟罗沙星引起神经系统不良反应[J]. 药物不良反应杂志, 2003, 5(1): 41.
[3] 于波, 成永晖. 氧氟沙星致老年震颤 2 例[J]. 中国临床药物杂志, 1998, 7(6): 308.
[4] 仲兆金, 谢少鸿, 从药物动力学观点看喹诺酮类药物的不良反

应. 国外医学抗生素分册, 2002, 23(2): 272.
[5] 曹丽荣, 冯建文, 王军. 简述喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用[J], 中华医药杂志, 2005, 5(1): 465.
[6] 王丽, 朱珊, 刘彩虹. 氟喹诺酮类药物不良反应 108 例分析及合理应用[J], 实用诊断与治疗杂志, 2006, 20(1): 44.
[7] 刘明亮. 氟喹诺酮诱发的肾功能障碍[J]. 国外医学抗生素分册 2003, 24(1): 34.

(收稿日期: 2009—05—08)

乳汁 HBVDNA 定量检测 50 例结果分析

谌建军 曲长春 李振军 曲 鹏 方翠艳 杨金枝
(鸡西市传染病院肝病治疗中心, 黑龙江 鸡西 158100)

中图分类号: R 525 文献标识码: B 文章编号: 1673—6567(2009)06—0094—01

乙型肝炎(HB)是一种严重危害人类健康的全球性疾病, 而我国是高度地方性流行区, 每年有百万的乙肝表面抗原携带者分娩, HBV 的围产期传播是重要的传播途径^[1]。鉴于母乳喂养的优越性, 乙肝血清学标志阳性的母亲能否哺乳值得探讨。我院采取了给乙肝血清学标志阳性的产妇的初乳进行 HBVDNA 定量检测, 对超过正常范围的要求人工喂养, 正常围内的支持母乳喂养。所有婴儿都按要求进行乙肝疫苗接种。现将乳汁 HBVDNA 定量检测 50 例结果分析如下。

临床材料

1 一般资料: 选择 2006 年 3 月~2008 年 4 月间乙型肝炎病毒携带者产妇 50 例, 年龄 22~37 岁, 平均 27.2 岁, 无其他合并症与并发症。均进行肝功、HBV—M(乙肝标志物)、血清 HBVDNA 及乳汁 HBVDNA 定量检测(正常值为 <1.0×10³copies/ml)。
2 实验方法: (1) 标本处理: 血清用 1 次性无菌真空采血管于产妇肘静脉处抽取静脉血 2ml, 乳汁采集于产妇分娩后 3~5 天内, 乳房局部清洗消毒, 用 1 次性无菌容器采取乳汁 2ml。(2) 试剂和方法: 采用奥地利 CLiniBio128C 酶标仪, 酶联免疫法检测 HBsAg、HBcAb、HBeAg、HBeAb, 乙型肝炎病毒诊断试剂盒为上海科华技术有限公司产品。杭州博日荧光定量 PCR 分析仪, HBVDNA 荧光定量 PCR 检测, 试剂盒由中山大学达安基因股份有限公司提供。
3 统计学处理: 计数资料采用 X² 检验, 计量资料采 t 检验。
4 结果: (1) 50 例乙型肝炎病毒携带者产妇检测结果, 其中大三阳(HBsAg 阳性、HBcAb 阳性、HBeAg 阳性) 16 例, 血清 HBVDNA 阳性 15 例(93.75%), 乳汁 HBVDNA 阳性 9 例(56.25%), 肝功异常 2 例(12.5); 小三阳(HBsAg 阳性、HBcAb 阳性、HBeAb 阴性) 29 例, 血清 HBVDNA 阳性 12 例(41.38%), 乳汁 HBVDNA 阳性 5 例(17.24%), 肝功异常 2 例(6.89%); 双阳(HBsAg 阳性、HBcAb 阳性) 5 例, 血清 HBVDNA 阳性 1 例(20%), 乳汁 HBVDNA 阳性 1 例(20%), 肝功均正常。接种 HBIG45 例, 其中两例为 3 天后肌注。乳汁 HBVDNA 的定量值为(3.47×10⁴±1.03×10⁴copies/ml), 血清 HBVDNA 定量值为(4.8×10⁶±2.5×10⁶copies/ml)。
(2) 检测结果表明: 乙型肝炎病毒携带者产妇乳汁 HBVDNA

定量值明显低于血清 HBVDNA 定量值(p<0.01), 有显著意义。其中大三阳产妇的乳汁 HBVDNA 定量值、血清 HBVDNA 定量值均较小三阳、双阳产妇阳性率高, 同时容易出现肝功异常。

讨 论

据 WHO 初步估计, 至 2002 年为止, 全球的 HBV 表面携带者有 4 亿多, 其中我国就占了约 1.3 亿, 且 30%~50% 是母婴传播所造成的^[2]。而 HBV 母婴传播途径最为活跃的因素之一就是乳汁传播^[3]。HBVDNA 是反映病毒复制和传染性的直接指标^[4], 用检测产妇的初乳中 HBV-DNA 来作为是否母乳喂养的标准, 被一些医院应用。产妇的初乳中 HBVDNA 阳性者, 婴儿感染概率会相当高。当新生儿或婴儿消化道黏膜(包括口腔、咽、食管、胃肠道等)任何一处因炎症导致水肿、通透性增加时, 当黏膜表面有破损时, 乳汁中的 HBV-DNA 就可以通过毛细血管进入血液循环, 造成孩子乙肝病毒感染。当孩子出现溢乳时, 如果耳、鼻部皮肤黏膜有破损, 乙肝病毒也会感染孩子。因此用 HBVDNA 的定量法对母乳的检出, 可以直接反映产妇传染性的强弱, 同时也对指导母乳喂养提供了可靠依据。通过以上分析, 我们认为大三阳产妇乳汁 HBVDNA 定量值阳性率最高, 但明显低于血清 HBVDNA 检测值, 新生儿和婴儿通过母乳喂养有感染的可能, 利用血清 HBVDNA 和乙肝标志物检测, 进行合理的哺乳指导, 对于不能开展 HBVDNA 检测的地区, 可以通过乙肝标志物情况给予产妇指导, 降低乙肝的感染率。

参考文献

[1] 中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会. 病毒性肝炎防治方案. 中华肝脏病杂志, 2000, 8: 324-329.
[2] 朱启熔. 重视乙型肝炎病毒母婴垂直传播的阻断[J]. 中华肝病杂志, 2003, 11(4): 199.
[3] 林静吟, 许岸高, 袁建寰, 等. 乙肝病毒母婴传播的可能途径研究[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 1997, 7(15): 7.
[4] 白艳丽, 李建平, 计玉仙. HBVDNA 与 HBVTRFIA 检测结果比较分析[J]. 现代检验医学杂志, 2004, 19(5): 43-44.

(收稿日期: 2009—05—25)